



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROGRAM BUDAYA KESELAMATAN
RS PRIMA HUSADA
TAHUN 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

KATA PENGANTAR

Dewasa ini keselamatan pasien menjadi isu penting yang diperbincangkan secara global. Keselamatan pasien menjadi komposisi penting dalam terciptanya pusat layanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas. Menurut Depkes RI (2008) Keselamatan pasien (patient safety) rumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman.

Kurangnya kemandirian dan sistem yang baik merupakan masalah yang dihadapi oleh penyedia pelayanan kesehatan untuk menyeberangi jurang dari perawatan yang bisa diberikan saat ini untuk mencapai perawatan yang seharusnya diberikan (IOM, 2000). Keselamatan Pasien/KP (Patient Safety) merupakan issue global dan nasional bagi rumah sakit dan merupakan komponen penting dari mutu pelayanan kesehatan, serta merupakan prinsip dasar dalam pelayanan pasien dan komponen kritis dalam manajemen mutu (WHO, 2004). Perhatian dan Fokus terhadap Keselamatan Pasien ini didorong oleh masih tingginya angka kejadian Tak Diinginkan (KTD) atau Adverse Event (AE) di rumah sakit baik secara global maupun nasional. KTD yang terjadi di berbagai negara diperkirakan sekitar 4.0 – 16.6 % dan hampir 50% diantaranya adalah kejadian yang dapat dicegah (Cahyono, 2008, Yahya, 2011). Adanya KTD tersebut selain berdampak pada peningkatan biaya pelayanan juga dapat membawa rumah sakit ke area blamming, menimbulkan konflik antara dokter/petugas kesehatan lain dan pasien, dan tidak jarang berakhir dengan tuntutan hukum yang dapat merugikan bagi rumah sakit (Depkes RI, 2006). Data KTD di Indonesia masih sangat sulit diperoleh secara lengkap dan akurat, tetapi dapat diasumsikan tidaklah kecil (KKP-RS, 2006).

Sebagai upaya memecahkan masalah tersebut dan mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih aman diperlukan suatu perubahan budaya dalam pelayanan kesehatan dari budaya menyalahkan individu menjadi suatu budaya dimana insiden dipandang sebagai kesempatan untuk memperbaiki sistem. Sistem pelaporan yang mengutamakan pembelajaran dari kesalahan dan perbaikan sistem pelayanan merupakan dasar budaya keselamatan. Meningkatnya kesadaran pelayanan kesehatan mengenai pentingnya mewujudkan budaya keselamatan pasien menyebabkan meningkatnya pula kebutuhan untuk mengukur budaya keselamatan. Perubahan budaya keselamatan dapat dipergunakan sebagai bukti keberhasilan implementasi program keselamatan pasien menjadi suatu budaya dimana insiden dipandang sebagai kesempatan untuk memperbaiki sistem. Sistem pelaporan yang mengutamakan pembelajaran dari kesalahan dan perbaikan sistem pelayanan merupakan dasar budaya keselamatan. Meningkatnya kesadaran pelayanan kesehatan mengenai pentingnya mewujudkan budaya keselamatan pasien menyebabkan meningkatnya pula kebutuhan untuk mengukur budaya keselamatan.

Perubahan budaya keselamatan dapat dipergunakan sebagai bukti keberhasilan implementasi program keselamatan pasien. menjadi suatu budaya dimana insiden dipandang sebagai kesempatan untuk memperbaiki sistem. Sistem pelaporan yang mengutamakan pembelajaran dari kesalahan dan perbaikan sistem pelayanan merupakan dasar budaya keselamatan. Meningkatnya kesadaran

pelayanan kesehatan mengenai pentingnya mewujudkan budaya keselamatan pasien menyebabkan meningkatnya pula kebutuhan untuk mrngukur budaya keselamatan. Perubahan budaya keselamatan dapat dipergunakan sebagai bukti keberhasilan implementasi program keselamatan pasien.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Budaya keselamatan pasien merupakan faktor yang paling penting dalam upaya untuk mengurangi resiko yang merugikan di rumah sakit dan meningkatkan keselamatan pasien. Budaya keselamatan pasien merupakan komposisi penting dalam pelayanan kesehatan dan telah dikaitkan dengan hasil pasien yang diperoleh pasien di rumah sakit. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program keselamatan pasien oleh petugas rumah sakit dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satu nya adalah budaya keselamatan pasien. Saat ini sudah banyak penelitian mengenai budaya keselamatan pasien dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan program keselamatan pasien. Walshe dan Boalden (2006) dalam Hamdani (2007) menyatakan bahwa penyebab utama kesalahan medis karena kesalahan sistem di rumah bukan karena kesalahan individu (NPSA, 2004).

Menurut Reason (1997) dalam Hamdani (2007) budaya keselamatan terdiri dari empat komponen (subculture) yaitu: 1) Informed culture. Budaya dimana pihak yang mengatur dan mengoperasikan sistem memiliki pengetahuan terkini tentang faktor-faktor yang menjelaskan keselamatan dalam suatu sistem. 2) Reporting culture. Budaya dimana anggota di dalamnya siap untuk melaporkan kesalahan atau near miss. Pada budaya ini organisasi dapat belajar dari pengalaman sebelumnya.

Konsekuensinya makin baik reporting culture maka laporan kejadian akan semakin meningkat Just culture.3) Budaya membawa atmosfer trust sehingga anggota bersedia dan memiliki motivasi untuk memberikan data dan informasi serta sensitif terhadap perilaku yang ada. Penting bagi setiap level di organisasi untuk bersikap jujur dan terbuka. 4) Learning culture. Budaya dimana setiap anggota mampu dan bersedia untuk menggali pengetahuan dari pengalaman dan data yang diperoleh serta kesediaan untuk mengimplementasikan perubahan dan perbaikan yang berkesinambungan (continuous improvement). Learning culture merupakan budaya belajar dari insiden dan near miss. Survei Hospital Survey On Patient Safety Culture mengukur budaya keselamatan pasien dari segi perspektif staf rumah sakit. Survei ini dapat mengukur budaya keselamatan pasien untuk seluruh staf rumah sakit dari housekeeping, bagian keamanan dari dokter sampai perawat.

Dari penjelasan di atas terpapar jelas mengenai bagaimana pentingnya penerapan budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Penerapan ini tidak hanya berguna untuk meningkatkan mutu dari suatu rumah sakit akan tetapi juga menjadi dasar terjaganya kondisi pasien sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan. Keselamatan pasien merupakan komponen terpenting dalam mutu pelayanan kesehatan. Rumah sakit sebagai organisasi pelayanan kesehatan harus mampu meningkatkan keselamatan pasien dengan mengusahakan terwujudnya budaya keselamatan. Dalam membangun budaya keselamatan, sangat penting bagi rumah

sakit untuk mengukur perkembangan budaya dengan melakukan pengukuran budaya secara berkala. Pengukuran pertama sangat penting sebagai data dasar yang akan dipergunakan sebagai acuan penyusunan program. Memiliki budaya keselamatan akan mendorong untuk dapat terciptanya lingkungan yang dapat mempertimbangkan semua komponen sebagai faktor- faktor yang ikut berkontribusi terhadap insiden yang telah terjadi. Hal ini menghindari kecenderungan untuk menyalahkan individu dan lebih melihat kepada sistem di mana individu tersebut bekerja.

1.2 TUJUAN

1.2.1 Tujuan Umum

Melakukan evaluasi terhadap program kerja yang telah dilakukan sebagai upaya membangun budaya keselamatan di Rumah Sakit Prima Husada Malang, khususnya sistem pelaporan.

1.2.2 Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan kesadaran tentang budaya keselamatan pasien.
- b. Mengidentifikasi area yang membutuhkan pengembangan dalam budaya keselamatan untuk menyusun program kerja selanjutnya.
- c. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program keselamatan pasien khususnya pelaporan insiden dan pembelajaran.

BAB II
KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

2.1 KEGIATAN POKOK

- a. Menciptakan budaya memberikan pelayanan yang aman secara konsisten untuk mencegah terjadinya kesalahan pada pelayanan berisiko tinggi.
- b. Menciptakan budaya melaporkan kesalahan dan insiden tanpa takut dikenakan sanksi atau teguran dan diperlakukan secara adil.
- c. Menciptakan budaya melaporkan kesalahan dan insiden tanpa takut dikenakan sanksi atau teguran dan diperlakukan secara adil.
- d. Mendorong komitmen pimpinan dalam mendukung staf seperti waktu kerja para staf, pendidikan, metode yang aman untuk melaporkan masalah dan hal lain untuk menyelesaikan masalah keselamatan.
- e. Mendorong komitmen pimpinan dalam mendukung staf seperti waktu kerja para staf, pendidikan, metode yang aman untuk melaporkan masalah dan hal lain untuk menyelesaikan masalah keselamatan.
- f. Evaluasi budaya secara berkala dengan metode seperti kelompok focus diskusi (FGD) wawancara dengan staf dan analisa data.
- g. Mendorong kerjasama dan membangun sistem dalam mengembangkan budaya perilaku yang aman.
- h. Mengembangkan budaya menanggapi perilaku yang tidak diinginkan pada semua staf pada semua jenjang di rumah sakit, termasuk manajemen, staf administrasi, staf klinis dan non klinis, dokter praktek mandiri, dan representasi pemilik.

2.2 RINCIAN KEGIATAN

Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan
Menciptakan budaya memberikan pelayanan yang aman secara konsisten untuk mencegah terjadinya kesalahan pada pelayanan berisiko tinggi.	- Identifikasi kategori pelayanan berisiko tinggi. - Membuat SPO pelayanan berisiko tinggi. - Sosialisasi pelayanan berisiko tinggi - Monitoring dan evaluasi pelayanan berisiko tinggi
Menciptakan budaya melaporkan kesalahan dan insiden tanpa takut dikenakan sanksi atau teguran dan diperlakukan secara adil	- FGD tentang pengembangan budaya keselamatan di Rumah Sakit Prima Husada Malang. - Pembuatan SPO pelaporan budaya keselamatan dan alur pelaporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan budaya keselamatan.

Mengembangkan kerjasama tim dan koordinasi untuk menyelesaikan masalah keselamatan pasien	- Rapat koordinasi rutin antara komite dengan pimpinan rumah sakit. - Koordinasi internal unit untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab unit. - Supervise tindak lanjut insiden keselamatan pasien.
Mendorong komitmen pimpinan dalam mendukung staf seperti waktu kerja para staf, pendidikan, metode yang aman untuk melaporkan masalah dan hal lain untuk menyelesaikan masalah keselamatan.	- Pengaturan jadwal kerja dan beban kerja staf sesuai dengan peraturan perundang- undangan. - Memfasilitasi pendidikan yang berguna untuk meningkatkan mutu pelayanan. - Pembuatan metode pelaporan dengan aplikasi untuk menjaga kemudahan dan kerahasiaan.
Mengembangkan sistem identifikasi dan mengenali masalah akibat perilaku yang tidak diinginkan (sembrono).	- Pembuatan buku kode etik Rumah Sakit Prima Husada Malang. - FGD untuk untuk identifikasi dan mengenali masalah akibat perilaku sembrono.
Evaluasi budaya secara berkala dengan metode seperti kelompok focus grup diskusi (FGD) wawancara dengan staf dan analisa data.	- FGD membahas peristiwa yang dilaporkan di budaya keselamatan secara anonim. - Monitoring dan evaluasi pelaku dan jenis perilaku yg bertentangan dengan budaya keselamatan.
Mendorong kerjasama dan membangun sistem dalam mengembangkan budaya perilaku yang aman.	- Sosialisasi SPO yang baru atau secara periodik bagi SPO yang lama. - Review dan update regulasi menyesuaikan dengan acuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Mengembangkan budaya menanggapi perilaku yang tidak diinginkan pada semua staf pada semua jenjang di rumah sakit, termasuk manajemen, staf administrasi, staf klinis dan non klinis, dokter praktek mandiri, dan representasi pemilik.	- Sosialisasi hasil identifikasi perilaku yang tidak diharapkan. - Sosialisai SPO pelaporan budaya keselamatan. - Pembuatan symbol kesepakatan pengembangan budaya keselamatan.

2.3 CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

Rincian kegiatan	Cara melaksanakan Kegiatan
- Identifikasi kategori pelayanan beresiko tinggi - Membuat SPO pelayanan beresiko tinggi - Sosialisasi pelayanan beresiko tinggi - Monitoring dan evaluasi pelayanan beresiko tinggi	Rapat koordinasi antar unit dan evaluasi laporan pelaksanaan pelayanan resiko tinggi dari sisi: - Insiden keselamatan pasien - Keselamatan dan Kesehatan kerja
- FGD tentang pengembangan budaya keselamatan di rumah sakit - Pembuatan SPO pelaporan budaya keselamatan dan laur pelaporan - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan budaya keselamatan	- Focus grup diskusi (FGD) dengan melibatkan semua unit dan profesi - Buat SPO sesuai kesepakatan semua - Evaluasi laporan budaya keselamatan
- Rapat koordinasi rutin antara komite dengan pimpinan RS. - Koordinasi internal unit untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab unit. - Surpervise tindak lanjut insiden keselamatan pasien.	- Rapat koordinasi - Rapat internal unit - Evaluasi laporan IKP dan tindak lanjutnya
- Pengaturan jadwal kerja dan beban kerja staf sesuai dengan peraturan perundangan undangan - Memfasilitasi Pendidikan yang berguna untuk meningkatkan mutu pelayanan - Pembuatan metode pelaporan dengan aplikasi untuk menjaga kemudahan dan Kerahasiaan	- Analisis beban kerja staf - Evaluasi pembuatan jadwal kerja staf - Program Pendidikan dan pelatihan staf - Penciptaan aplikasi pelaporan budaya keselamatan
- Pembuatan buku kode etik rumah sakit Rumah Sakit Prima Husada Malang - FGD untuk identifikasi dan mengenali masalah akibat prilaku sembrono.	- Buat buku kode etik rumah sakit Rumah Sakit Prima Husada Malangyang mengacu KODERSI (Kode Etik Rumah Sakit Indonesia) - Diskusi melibatkan semua unit

[illegible]

2.5 EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

2.5.1 Pencatatan

- a. Kegiatan survei budaya keselamatan pasien
Kegiatan survei budaya keselamatan pasien menggunakan kuesioner Hospital Survey on Pasien Safety Culture yang disusun oleh AHRQ
- b. Pencatatan capaian indikator mutu sasaran keselamatan pasien
Pencatatan dilakukan oleh PIC mutu ruangan dan dilaporkan setiap bulan ke komite
- c. Pencatatan laporan insiden keselamatan pasien
Pencatatan laporan insiden keselamatan pasien dilakukan sesuai SPO alur pelaporan insiden keselamatan pasien
- d. Pencatatan dan pelaporan insiden terkait budaya keselamatan atau perilaku yang tidak diinginkan dilakukan dengan menggunakan formulir yang terdapat dalam pedoman budaya keselamatan rumah sakit.

2.5.2 Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan

- a. Pelaporan kegiatan survey budaya keselamatan pasien dilaporkan pada Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk ditindak lanjuti
- b. Pelaporan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana budaya keselamatan pasien diterapkan di Rumah Sakit Prima Husada Malang

2.6 PEMBIAYAAN DAN ANGGARAN

NO	RINCIAN KEGIATAN/ URAIAN	JUMLAH KEBUTUHAN	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	FGD (tiap triwulan/ 4x dalam 1 tahun	20	orang	Rp. 2000	Rp. 40.000

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Program Budaya Keselamatan merupakan upaya strategis dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit. Melalui penerapan budaya keselamatan yang kuat, seluruh tenaga kesehatan dan staf pendukung diharapkan memiliki kesadaran, sikap, dan perilaku yang mengutamakan keselamatan dalam setiap proses pelayanan.

Pelaksanaan program ini mencakup berbagai aspek, antara lain peningkatan pengetahuan dan kompetensi SDM, pelaporan insiden keselamatan pasien, komunikasi efektif, serta penerapan standar prosedur operasional yang konsisten. Dengan adanya komitmen dari seluruh jajaran manajemen dan staf, budaya keselamatan dapat terintegrasi dalam setiap aktivitas pelayanan sehingga mampu meminimalkan risiko dan mencegah terjadinya insiden yang merugikan pasien.

3.2 Saran

Agar pelaksanaan Program Budaya Keselamatan berjalan optimal dan berkelanjutan, maka disarankan:

- Pimpinan rumah sakit perlu terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung implementasi budaya keselamatan melalui kebijakan, pengawasan, dan penyediaan sumber daya.
- Dilakukan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman seluruh staf terkait keselamatan pasien dan pelaporan insiden.
- Mendorong terciptanya budaya pelaporan yang tidak menyalahkan (*no blame culture*) sehingga setiap insiden dapat dilaporkan dan dianalisis untuk perbaikan sistem.
- Melakukan audit, supervisi, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan.
- Seluruh unit kerja diharapkan aktif berpartisipasi dalam penerapan budaya keselamatan sebagai tanggung jawab bersama.

Malang, 3 Maret 2026

Penyusun,
Ketua Komite Mutu



dr. Diah Puspita Rifasanti, Sp.M

Mengetahui,
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M.Kes